DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PRODUCTO

Vision & Scope Document

Sistema de Atención Médica Remota

Versión 0.1

Proyecto / Sistema	Sistema de Atención Médica Remota
Versión del documento	0.1
Fecha de elaboración	04/05/2026
Responsable (BA)	[Nombre del Analista de Negocio]
Patrocinador	Ing. Armando Cabrera Silva
Organización	Universidad Técnica Particular De Loja
Estado	Borrador
Clasificación	Interno

📋 **Estándares de referencia**
Este documento sigue las guías del IEEE Std 830-1998 (SRS), BABOK v3 (IIBA), la plantilla de Vision & Scope de Karl Wiegers (Microsoft Press, 2013) y el marco de Gottesdiener (2005). Los campos marcados con [texto en cursiva] son instrucciones para el equipo — deben reemplazarse con el contenido real del proyecto.

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos 1
1. Control de Cambios 1
2. Aprobaciones 1
3. Introducción 1
3.1 Propósito del documento 1
3.2 Alcance del documento 1
3.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 1
3.4 Referencias 1
4. Declaración del Problema (Problem Statement) 1
5. Enunciado de Visión del Producto 1
6. Objetivos de Negocio 1
7. Análisis de Interesados 1
7.1 Registro de interesados 1
7.2 Perfil de usuarios clave 1
8. Alcance del Producto 1
8.1 Declaración de alcance (Scope Statement) 1
8.2 Características principales del sistema 1
8.3 Diagrama de contexto del sistema 1
9. Restricciones, Suposiciones y Dependencias 1
9.1 Restricciones 1
9.2 Suposiciones 1
9.3 Dependencias 1
10. Estrategia de Mitigación de Riesgos de Requisitos 1
11. Criterios de Éxito del Proyecto 1
12. Anexos 1
Anexo A — Lista de verificación del documento 1
Anexo B — Instrucciones de uso de esta plantilla 1

1. Control de Cambios

📝 Registre cada revisión del documento. Los documentos de requisitos deben estar bajo control de versiones (BABOK v3, §10.42).

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Estado
0.1	04/05/2026	Grupo Multi Función	Versión inicial del documento	Borrador

2. Aprobaciones

📝 Identifique a todos los stakeholders que deben aprobar este documento antes de iniciar la elicitación detallada.

Nombre	Rol / Cargo	Organización	Fecha	Firma
Ing. Armando Cabrera Silva	[Patrocinador]	[Organización]	07/04/2026	
Pedro Yépez	Líder técnico / Backend	[Organización]	07/04/2026	
Rafaela Palacios	Arquitecta de software	[Organización]	07/04/2026	
Hansell Benavides	Diseñador Frontend	[Organización]	07/04/2026	
Jean Cuenca	Ingeniero de Seguridad	[Organización]	07/04/2026	
Sergi Montaño	Diseñador UX/UI	[Organización]	07/04/2026	.
Andy Veintimilla	Base de Datos	[Organización]	07/04/2026	

3. Introducción

3.1 Propósito del documento

📝 Explique en 2-3 párrafos el propósito de este documento y su audiencia prevista.

El presente documento tiene como propósito definir la visión general del Sistema de Atención Médica Remota, estableciendo su alcance, objetivos y valor esperado dentro del contexto de la atención médica a distancia. Este documento proporciona una comprensión compartida del problema que se busca

resolver, así como de las necesidades principales de los usuarios y las capacidades que el sistema deberá ofrecer para garantizar una atención oportuna, continua y segura.

La audiencia prevista incluye a los interesados del sistema, tales como desarrolladores, analistas de sistemas, profesionales de la salud, gestores del proyecto, entidades reguladoras y cualquier otra parte involucrada en el diseño, implementación y uso del sistema.

3.2 Alcance del documento

📝 Indique qué sistemas, procesos o áreas organizacionales cubre este documento.

Este documento describe la visión general del Sistema de Atención Médica Remota, incluyendo sus objetivos de negocio, el problema que se busca resolver y las necesidades de los usuarios y la descripción de las funcionalidades esperadas. Define a los principales interesados involucrados en el proyecto.

Fuera del alcance quedan los diseños de arquitectura, modelos de datos, ni descripciones exhaustivas de implementación.

Tampoco contempla cronogramas, estimaciones de costos o pruebas del sistema.

3.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

📝 Incluya el glosario de términos de negocio relevantes. Un glosario compartido elimina malentendidos entre el equipo (Gottesdiener, 2005, §2.2).

Término / Acrónimo	Definición
BA	Business Analyst — Analista de Negocio
IR	Ingeniería de Requisitos
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional

3.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE.
- IIBA (2015). A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), v3. IIBA.
- Wiegers, K. & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3ª ed.). Microsoft Press.
- Gottesdiener, E. (2005). The Software Requirements Memory Jogger. GOAL/QPC.
- [Agregar otras referencias relevantes al proyecto]

4. Declaración del Problema (Problem Statement)

📝 Utilice la plantilla de Gottesdiener (2005, §2.1) para articular el problema de negocio que este sistema resolverá. Esto es clave antes de definir la solución.

El problema de:

A causa de la falta de instituciones médicas correctamente equipadas y capacitadas los pacientes que requieren atención médica fuera del entorno hospitalario enfrentan dificultades para recibir asistencia oportuna y continua, poniendo en riesgo así (**la integridad del paciente)**, empeorando (**la priorización de atención)** de pacientes, (**perdiendo el seguimiento)** de la evolución de los casos individuales causando un (**empeoramiento en su condición)**. Esto (**incrementa la carga innecesaria de trabajo)** del personal de salud y por consecuencia (**empeora su servicio), (afectando así a la organización y gestión)** del centro médico

Afecta a:

* **Pacientes: (** En recuperación domiciliaria, que requieren control periódico, zonas alejadas o con movilidad reducida**,** en situación de emergencia **)**

* **Centros de Atención Médica:** (Hospitales o clínicas).

* **Profesionales de la Salud / Médicos:** (Encargados de diagnosticar, monitorear y dar seguimiento).

El impacto de este problema es:

Peligro para la vida del paciente: Las emergencias médicas tardan demasiado en ser atendidas porque no hay seguridad de que un centro médico responda rápido.
Desorden en la atención: Cuando hay muchos pacientes pidiendo ayuda al mismo tiempo, el sistema colapsa porque no sabe a quién priorizar ni cómo asignar a los médicos.
Falta de seguimiento médico: Los pacientes tienen dificultades para continuar con sus chequeos regulares si deben acudir físicamente al centro de salud, perdiendo el contacto con su doctor para controlar su recuperación.
Enfermedades que se agravan: Al no poder vigilar los signos vitales del paciente desde casa, los médicos pierden la oportunidad de actuar antes de que la salud del paciente empeore.

---

1. Degradación de la Integridad del Paciente: Al no existir una asistencia oportuna y continua, las condiciones que podrían tratarse de forma preventiva escalan a estados críticos, aumentando la tasa de complicaciones evitables y poniendo en riesgo la salud del paciente en situaciones de emergencia.

2. Ineficiencia en el Triaje y Priorización: Al no poder distinguir con precisión la gravedad de cada caso a distancia, el sistema colapsa al intentar atender todas las solicitudes por igual, dejando desprotegidos a los pacientes con cuadros de mayor riesgo y urgencia real.

3. Ruptura del Seguimiento Clínico: Sin un flujo de información constante, los médicos tratantes trabajan de forma reactiva y no proactiva; esto causa que se ignoren señales de alerta tempranas, resultando en reingresos hospitalarios recurrentes y tratamientos menos efectivos.

4. Sobrecarga y Desgaste del Personal de Salud: Los profesionales de la salud deben gestionar emergencias y consultas bajo presión extrema y con información incompleta, lo que incrementa el agotamiento laboral. Este estrés sistémico reduce la capacidad de respuesta y disminuye la calidad humana y técnica del servicio prestado.

5. Saturación del Sistema de Salud: Esto genera un colapso en la atención presencial, donde el personal debe dividir sus limitados esfuerzos entre pacientes hospitalizados y aquellos que acuden por falta de un seguimiento remoto adecuado, empeorando la experiencia general de todos los usuarios.

Una solución exitosa permitiría:

Ayuda garantizada en minutos: Crear un sistema de alertas donde el paciente pide ayuda y la solicitud llega a varios centros de salud al mismo tiempo, asegurando que alguien responda en menos de 3 minutos.
Atender primero al más grave: Un sistema inteligente que sepa organizar automáticamente a los médicos y recursos para atender primero a los pacientes que están en mayor peligro de vida.
Habilitar la atención médica por teleconsulta: Implementar un sistema de consultas médicas telemáticas que permita al doctor y al paciente conectarse a distancia para dar un seguimiento continuo a su evolución y tratamiento sin salir de casa.
Vigilancia médica remota: Conectar los equipos de salud del paciente a internet para que el sistema avise al médico de inmediato si algo anda mal (alertas automáticas), permitiéndole dar un tratamiento rápido y enviar recetas digitales.

5. Enunciado de Visión del Producto

📌 **Plantilla de Enunciado de Visión**
"Para [clientes objetivo] que [necesidad u oportunidad], el [nombre del producto] es un [categoría del producto] que [beneficio clave / razón de compra]. A diferencia de [alternativa competidora / sistema actual], nuestro producto [diferenciación principal]." — Moore (1999) en Wiegers (2013)

Clientes objetivo	Pacientes cuya situación de salud les dificulta mucho atender de forma presencial a recibir consultas médicas
Necesidad / oportunidad	En la actualidad el sistema de salud no cuenta con un medio por el cual ayudar a pacientes incapaces de asistir presencialmente a los centros médicos
Nombre del producto	SAMR Sistema de Atención Médica Remota
Categoría del producto	Aplicación web interna
Beneficio clave (reason to buy)	La oportunidad de recibir atención médica remota
Alternativa / sistema actual	Hoy en día el paciente solo la opción de atención presencial
Diferenciación principal	Destaca ya que no existe ningún sistema que ofrezca una experiencia similar

Enunciado de visión completo (redactar aquí):

Para pacientes cuya situación de salud les dificulta asistir de forma presencial a recibir consultas médicas que actualmente no cuentan con un medio eficaz para obtener ayuda profesional sin salir de su hogar, el SAMR (Sistema de Atención Médica Remota) es una aplicación web interna que brinda la oportunidad de recibir atención médica remota de calidad y oportuna.
A diferencia de la situación actual, donde el paciente solo tiene la opción de la atención de manera presencial de manera obligatoria, nuestro producto destaca ya que no existe ningún sistema que ofrezca una experiencia similar, eliminando las barreras de la movilidad y garantizando el acceso a la salud desde cualquier ubicación.

6. Objetivos de Negocio

📝 Los objetivos de negocio justifican la inversión en el proyecto. Deben ser SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo definido (BABOK v3, §1.3.1).

ID	Objetivo (SMART)	Métrica de éxito	Plazo
OB-01	Reducir el tiempo promedio de agendamiento de citas médicas.	Tiempo de respuesta en asignación de turnos ≤ 3 minutos.	[3 meses post-lanzamiento]
OB-02	Digitalizar la totalidad de las historias clínicas de pacientes recurrentes.	100% de consultas registradas en formato digital.	[Plazo]
OB-03	Disminuir la tasa de inasistencia de pacientes.	[Métrica 3]	[Plazo]

7. Análisis de Interesados

📝 Identifique a todos los grupos que afectan o son afectados por el sistema. Clasifíquelos según la Matriz Poder/Interés (Wiegers, 2013, Cap. 6).

7.1 Registro de interesados

ID	Nombre / Grupo	Rol en el proyecto	Poder	Interés	Estrategia de gestión
ST-01	[Patrocinador]	[Financia y aprueba]	Alto	Alto	Gestionar de cerca

ID	Nombre / Grupo	Rol en el proyecto	Poder	Interés	Estrategia de gestión
ST-02	[Usuarios finales]	[Operan el sistema]	Bajo	Alto	Mantener informados
ST-03	[Equipo de desarrollo]	[Construye el sistema]	Medio	Alto	Colaborar activamente
ST-04	[Regulador / externo]	[Ente de control]	Alto	Bajo	Mantener satisfecho
ST-05	[Interesado 5]	[Rol]	[Poder]	[Interés]	[Estrategia]

7.2 Perfil de usuarios clave

📝 Para cada clase de usuario, documente sus características, necesidades y nivel técnico (Wiegers, 2013, Cap. 6).

[Nombre de la clase de usuario, p.ej. Coordinador de ventas]	
Descripción	[Descripción del perfil: quién es, qué hace habitualmente]
Necesidades clave	[Qué problemas necesita resolver con el nuevo sistema]
Nivel técnico	[Bajo / Medio / Alto — experiencia con sistemas similares]
Frecuencia de uso	[Diario / Semanal / Ocasional]
Restricciones	[Accesibilidad, idioma, dispositivo, normativa aplicable]

8. Alcance del Producto

8.1 Declaración de alcance (Scope Statement)

📝 Delimite claramente qué incluye y qué excluye el sistema. La ambigüedad en el alcance es una de las principales causas de scope creep (Wiegers, 2013, Cap. 5).

✅ DENTRO del alcance	❌ FUERA del alcance
[Funcionalidad 1 que el sistema DEBE hacer]	[Funcionalidad que NO será desarrollada en esta versión]
[Funcionalidad 2 dentro del alcance]	[Fuera del alcance 2]
[Funcionalidad 3]	[Fuera del alcance 3]

8.2 Características principales del sistema

📝 Enumere las características de alto nivel (features) del sistema — no son requisitos detallados, sino capacidades macro (IEEE 830-1998, §5.2).

ID	Característica	Descripción breve	Prioridad
C-01	[Gestión de usuarios]	[Registro, autenticación y control de acceso]	Alta
C-02	[Característica 2]	[Descripción de la característica 2]	Media
C-03	[Característica 3]	[Descripción de la característica 3]	[Prioridad]
C-04	[Característica 4]	[Descripción]	[Prioridad]

8.3 Diagrama de contexto del sistema

📝 Inserte aquí el diagrama de contexto que muestra el sistema como una caja negra y sus relaciones con actores y sistemas externos (Gottesdiener, 2005; Wiegers, 2013, Cap. 5). Use herramientas como draw.io, Lucidchart o Visio.

[Inserte aquí el Diagrama de Contexto del Sistema]
Formato: imagen PNG o JPG exportada de draw.io / Lucidchart

9. Restricciones, Suposiciones y Dependencias

9.1 Restricciones

📝 Las restricciones limitan las opciones de diseño o implementación: tecnológicas, legales, de presupuesto, etc. (IEEE 830-1998, §5.3).

ID	Tipo	Descripción
R-01	Tecnológica	[El sistema debe ser compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge en sus versiones actuales]
R-02	Legal/Normativa	[Debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDP) aplicable]
R-03	Presupuesto	[El presupuesto disponible es de USD [X]]
R-04	Tiempo	[El sistema debe estar operativo antes del [fecha]]

9.2 Suposiciones

📝 Condiciones que se asumen verdaderas para elaborar este documento. Si alguna suposición resulta falsa, el alcance o la viabilidad pueden verse afectados.

- [SA-01] [Los usuarios tendrán acceso a internet de banda ancha en sus estaciones de trabajo.]
- [SA-02] [Los datos del sistema legacy estarán disponibles para migración antes del inicio del desarrollo.]
- [SA-03] [El equipo de desarrollo contará con un BA dedicado durante todo el proyecto.]
- [SA-04] [Los interesados clave estarán disponibles para sesiones de elicitación de al menos 2 h por semana.]
- [Agregue más suposiciones según el contexto del proyecto]

9.3 Dependencias

📝 Sistemas, proyectos o decisiones externas de las que depende este proyecto.

ID	Dependencia	Impacto si no se cumple	Responsable
D-01	[Sistema X debe proveer API de integración]	[No se podrá sincronizar datos en tiempo real]	[Nombre]
D-02	[Dependencia 2]	[Impacto 2]	[Responsable]

10. Estrategia de Mitigación de Riesgos de Requisitos

📝 Identifique y clasifique los riesgos específicos del proceso de requisitos. Esta es una actividad de 'preparación del escenario' (Gottesdiener, 2005, §2.3). Use escala: Alta / Media / Baja para probabilidad e impacto.

ID	Riesgo de requisito	Prob.	Impacto	Nivel	Estrategia de mitigación
RR-01	Falta de involucramiento de usuarios clave	Alta	Alta	Crítico	Establecer acuerdos de participación mínima; asignar representante de usuario dedicado
RR-02	Requisitos ambiguos o incompletos	Alta	Alta	Crítico	Usar plantillas de especificación; aplicar revisiones de requisitos por pares
RR-03	Scope creep (expansión no controlada)	Media	Alta	Alto	Gestión formal de cambios; línea base de alcance aprobada
RR-04	Conflicto entre stakeholders	Media	Media	Medio	Talleres de priorización; mediación por BA neutral
RR-05	[Riesgo identificado para este proyecto]	[Prob.]	[Imp.]	[Nivel]	[Acciones de mitigación]

11. Criterios de Éxito del Proyecto

📝 Defina condiciones verificables que indicarán que el proyecto fue exitoso. Deben vincularse con los Objetivos de Negocio de la sección 6.

ID	Criterio de éxito	Forma de medición	OB relacionado
CE-01	[El tiempo de cotización se reduce ≥ 50% en los primeros 3 meses]	[Promedio de logs del sistema]	OB-01
CE-02	[Al menos el 80% de usuarios adoptan el sistema en el primer mes]	[Tasa de adopción en analytics]	OB-02
CE-03	[Criterio de éxito 3]	[Cómo se medirá]	[OB-0X]

12. Anexos

Anexo A — Lista de verificación del documento

📝 Use esta lista antes de enviar el documento para revisión y aprobación.

Criterio de calidad	✅	❌
El enunciado de visión sigue la plantilla de Moore / Wiegers	☐	☐
Los objetivos de negocio son SMART y tienen métricas	☐	☐
Todos los stakeholders identificados están en el registro	☐	☐
El alcance delimita claramente qué está dentro y qué está fuera	☐	☐
El glosario cubre todos los términos especializados del dominio	☐	☐
Los riesgos de requisitos tienen estrategias de mitigación asignadas	☐	☐
El diagrama de contexto del sistema está incluido	☐	☐
El documento ha sido revisado por al menos un stakeholder clave	☐	☐
Hay al menos un criterio de éxito por cada objetivo de negocio	☐	☐
El control de cambios y aprobaciones están completos	☐	☐

Anexo B — Instrucciones de uso de esta plantilla

1. Reemplace todos los textos en [corchetes en cursiva] con el contenido real del proyecto.
2. Los textos 📝 en gris son instrucciones para el equipo de análisis — deben eliminarse del documento final.
3. Mantenga el control de versiones actualizado en la sección 1 en cada revisión.
4. Obtenga las firmas de aprobación en la sección 2 antes de proceder con la elicitación detallada.
5. Actualice la Tabla de Contenidos (clic derecho → Actualizar campo) antes de imprimir o enviar.
6. Use plantillas de requisitos adicionales de Wiegers (2013) para el SRS una vez que este documento esté aprobado.

📚 **Estándares y referencias completas de esta plantilla**
• IEEE Std 830-1998 — Secciones §5.2 (características), §5.3 (restricciones), §5.4 (suposiciones) • BABOK v3 (IIBA, 2015) — §1.3.1 Objetivos SMART, §10.42 Control de versiones, §8.1 Análisis de stakeholders • Wiegers & Beatty (2013) — Cap. 5 Vision & Scope Document, Cap. 6 Voice of the User • Gottesdiener (2005) — §2.1 Problem Statement, §2.2 Glossary, §2.3 Risk Mitigation Strategy • Moore (1999) — Plantilla de Enunciado de Visión (citado en Wiegers, 2013)